EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
INTERVENCIÓN – ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO ST-ELEVADO

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	• Las enfermedades cardiovasculares (ECV), principalmente la cardiopatía isquémica, son las principales causas de mortalidad y discapacidad en los países de las Américas. Panamerican Health Organization PAHO. World Health Organization Regional Office in Americas/Panamerican Health Organization. Cardiovascular disease burden in the Region of the Americas, 2000-2019 • Según datos preliminares de la Dirección de Vigilancia de la Salud, en Costa Rica los fallecimientos por infarto agudo de miocardio aumentaron en un 11% durante el año 2022, contabilizando un total de 2.144 casos ese año y 1.928 en el 2021. Del total de fallecimientos durante el 2022, 869 corresponden a mujeres (40%) y 1.275 a hombres. (60%). Asimismo, el grupo etario más afectado son las personas mayores de 75 años, las cuales registran 1.178 defunciones del total reportado en el 2022. Ministerio de Salud. Gobierno de Costa Rica. Fallecimientos por Infarto aumentaron en un 11% durante el año 2022. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/60-noticias-2023/1682-fallecimientos-por-infarto-agudo-de-miocardio- • En términos de legislación, en el Sistema Costarricense de Información Jurídica no se encontró información relevante asociada a esta intervención en una búsqueda realizada en las fechas 2 y 3 de noviembre de 2023 con los términos: atención/infarto miocardio/intervención coronaria percutánea • El Plan Estratégico Institucional de la CCSS, en la línea estratégica 1-A se orienta hacia el reforzamiento de la atención integral de la salud mental, enfermedades crónicas y cardiovasculares y cáncer, asegurando el tratamiento de forma oportuna, con calidad y accesible a la población a fin de generar una disminución en la carga de la enfermedad. CCSS, Plan Estratégico Institucional PEI 2023-2033. Dirección de Planificación Institucional.
Evidencia	• Los programas de rehabilitación cardiaca y prevención secundaria están recomendados en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST). Evidencia: Clase I, Nivel B. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. • Todos los pacientes hospitalizados con un diagnóstico primario de IAMCEST deben derivarse tempranamente a un programa de rehabilitación cardíaca ambulatoria y prevención secundaria. Thomas RJ, Balady G, Banka G, Beckie TM, Chiu J, Gokak S, Ho PM, Keteyian SJ, King M, Lui K, Pack Q, Sanderson BK, Wang TY. 2018 ACC/AHA

	clinical performance and quality measures for cardiac rehabilitation: a report of the American College ofCardiology/American Heart Association Task Force on Performance Measures. Circ Cardiovasc Qual Outcomes.2018;11: e000037. doi: 10.1161/HCQ.0000000000000037.
Consideraciones de Implementación	Disponibilidad y acceso a Programas de Rehabilitación Cardiovascular
Normativa Técnica	No se identificó normativa técnica institucional vigente que sea aplicable para los efectos de la evaluación, en una búsqueda realizada en las siguientes fechas: 1 al 14 de noviembre/2023, utilizando los siguientes términos: ccss/normativa/atención/infarto/miocardio en el catálogo de publicaciones institucional de la CCSS (https://www.ccss.sa.cr/normativa) y a través del enlace rápido “protocolos, normas y guías” de la Biblioteca Nacional de Salud BINASSS (https://www.binasss.sa.cr/protocolos/protocolos.htm)
Costo / Efectividad	No se identificaron estudios de costo/efectividad específicos sobre la rehabilitación cardiovascular/prevención secundaria en pacientes egresados con IAMCEST que puedan ser aplicables a la realidad del país, en una búsqueda realizada en las siguientes fechas: 1° al 21 de noviembre, 2023, utilizando los siguientes descriptores en ciencias de la salud (MESH) de la biblioteca nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM): “Myocardial, Infarction"[Mesh]) AND " Cardiac Rehabilitation/economics"[Mesh] en las bases de datos biomédicos de la National Library of Medicine NLM, Pub Med, Medscape, BMJ Best Practice, Scielo, Cochrane Library, Clinical Key, Medline, Ovid, Jaypee digital, New England of Medicine. A nivel local no se identificaron investigaciones sobre el tema, en el Hub virtual de economía de la salud “Imputs para mejorar el sistema de salud costarricense”. https://www.binasss.sa.cr/economia/experto1.php#MATERIAL
Objetivo (s) de la Evaluación	Identificar la proporción de casos por IAMCEST egresados, con referencia a un programa de rehabilitación cardiaca y prevención secundaria.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Los casos egresados por IAMCEST elevado son referidos a un programa de rehabilitación cardiaca y prevención secundaria?
Indicadores asociados a la intervención	• Proporción de casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado egresados con referencia a un programa de rehabilitación cardiaca y prevención secundaria.
Anexos	NO APLICA
Referencias Bibliográficas	Authors/Task Force Members: Robert A. Byrne *†,(Chairperson) (Ireland), Xavier Rossello ‡(Task Force Co-ordinator) (Spain), J.J. Coughlan ‡ ,(Task Force Co-ordinator) (Ireland), Emanuele Barbato (Italy), Colin Berry (United Kingdom), Alaide Chieffo (Italy), Marc J. Claeys (Belgium),

Gheorghe-Andrei Dan (Romania), Marc R. Dweck (United Kingdom), Mary Galbraith (United Kingdom), Martine Gilard (France),Lynne Hinterbuchner (Austria), Ewa A. Jankowska (Poland), Peter Jüni (United Kingdom), Takeshi Kimura (Japan), Vijay Kunadian (United Kingdom), Margret Leosdottir (Sweden), Roberto Lorusso (Netherlands), Roberto F.E. Pedretti (Italy), Angelos G. Rigopoulos (Greece), Maria Rubini Gimenez (Germany), Holger Thiele (Germany), Pascal Vranckx (Belgium), Sven Wassmann (Germany), Nanette Kass Wenger (United States of America), Borja Ibanez *† (Chairperson) (Spain), and ESCScientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary síndromes. Developed by the task force on the management of acute coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC)(2023) European Heart Journal and European Heart Journal - Acute Cardiovascular Care

Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, Amsterdam E, Bhatt DL, Birtcher KK, Blankstein R,Boyd J, Bullock-Palmer RP, Conejo T, Diercks DB, Gentile F, Greenwood JP, Hess EP, Hollenberg SM, Jaber WA, Jneid H, Joglar JA, Morrow DA, O'Connor RE, Ross MA, Shaw LJ. 2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR guideline for the evaluation and diagnosis of chest pain: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2021;144: e368–e454. doi: 10.1161/CIR.0000000000001029

Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, White HD; Executive Group on behalf of the Joint European Society of Cardiology (ESC)/American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA)/World Heart Federation (WHF) Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction.. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). J Am Coll Cardiol. 2018 Aug 23. pii: S0735-1097(18)36941-9. doi: 10.1161/CIR.0000000000000617.

Jneid H, Addison D, Bhatt DL, Fonarow GC, Gokak S, Grady KL, Green LA, Heidenreich PA, Ho PM, Jurgens CY, King ML, Kumbhani DJ, Pancholy S. 2017 AHA/ACC Clinical Performance and Quality Measures for Adults With ST-Elevation and Non-ST-Elevation Myocardial Infarction: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Performance Measures. J Am Coll Cardiol. 2017 Oct 17;70(16):2048-2090. doi: 10.1016/j.jacc.2017.06.032.

Schiele F, Gale CP, Bonnefoy E, Capuano F, Claeys MJ, Danchin N, Fox KA, Huber K, Iakobishvili Z, Lettino M, Quinn T, Rubini Gimenez M, Bøtker HE, Swahn E, Timmis A, Tubaro M, Vrints C, Walker D, Zahger D, Zeymer U, Bueno H. Quality indicators for acute myocardial infarction: A position paper of the Acute Cardiovascular Care Association. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2017 Feb;6(1):34-59. doi: 10.1177/2048872616643053